



抗精神病药物

作者: [Matcheri S. Keshavan](#), MD, Harvard Medical School
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 7月 2025 | 修改的 1月 2026

精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常和不恰当的行为（包括紧张症）。许多精神疾病能引起精神病症状——参见[精神分裂症和相关障碍简介](#)。

抗精神病药物可有效减少或消除精神病症状。虽然抗精神病药物最常用于治疗[精神分裂症](#)，但它们对所有可以引起以上精神症状的疾病均有效，如精神分裂症、[躁狂](#)、[痴呆](#)或由像[安非他命](#)这类物质引起的中毒反应。（见表[抗精神病药物](#)。）

在消除当前症状后，根据精神病的病因，患者可能需要继续使用抗精神病药物，以减少复发的可能。

抗精神病药物如何发挥作用

抗精神病药物是通过影响信息在脑细胞间的传递而起作用。

据估计，成年人的大脑有超过 860 亿个被称为神经元的神经细胞。每个脑神经元都有一根长长的纤维，称为轴突，负责将信息传递给其他神经元（见图[神经的典型结构](#)）。就像巨大的电话总机连接的电线一样，每一个神经元与几千个神经元相联系。

信息以电冲动的形式沿着轴突向下传送。当冲动传到轴突末梢时，被称为神经递质的特殊化学物质微量释放，从而将信息传递给下一个细胞。接受信息的细胞上有受体，能够接受相应的神经递质产生新的信号。

出现精神病症状是因为对多巴胺类神经递质敏感的细胞活动过度所致。所以，抗精神病药物通过阻断受体来减弱细胞间的信息传递。

不同的抗精神病药阻断不同类型的神经递质的效应不同。所有抗精神病药物都会调节多巴胺水平。第二代抗精神病药物（例如阿塞那平、氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利培酮和齐拉西酮）可阻断 5-羟色胺（另一种神经递质）受体。新型抗精神病药物，如 Xanomeline，通过其对乙酰胆碱的作用起作用。

氯氮平也可以阻断很多其他受体，显然是治疗精神病症状最有效的药物。但它的副作用比较严重，且需要监测血象，所以不常使用。

抗精神病药物的类型

抗精神病药物分为 3 组：

- 第一代（老的、传统的、典型的）抗精神病药物
- 第二代（非典型）抗精神病药物
- 新型抗精神病药物

目前，美国处方的抗精神病药物约有 95% 是第二代抗精神病药物。第二代抗精神病药物可缓解阳性症状（如幻觉）、阴性症状（如情感缺乏）和认知功能损害（如心理功能受损和注意力狭窄）。不过，研究还不清楚这些药物是否比第一代抗精神病药物更能缓解症状，只是因为它们的严重副作用较少，而且有时比第二代抗精神病药物更便宜，所以人们更愿意用这些药物。

氯氮平，作为最早开发的第二代抗精神病药物，对多达一半对其他抗精神病药物无效的患者有效。但由于其严重的副作用，通常只用于对其他抗精神病药物无效的患者。

一些第一代和第二代抗精神病药物可以作为长效注射制剂，只需每个月或两个月给予一次。这些制剂对很多患者有用，包括那些不能每天可靠服用口服药物的人。

目前正在研究具有新作用的抗精神病药物。

表格		
抗精神病药物		
药物	一些潜在副作用	注释
第一代抗精神病药物		
	口干	
氯丙嗪	视力模糊	
氟奋乃静*	癫痫发作	
氟哌啶醇*	心动过速和血压下降	
Loxapine	便秘	不良作用较常发生于老年人、平衡功能受损或有严重疾病的人。
茚酮	突然发生但可逆的震颤、肌肉僵硬，可进行性发展为肌肉强直	
奋乃静		在服用硫利达嗪期间，建议做眼科检查和心电图 (ECG)。
匹莫齐特		
硫利达嗪	面部或手臂的不自主运动（迟发性运动障碍）	
硫噻吩	肌肉强直、发热、血压升高、精神症状（ 抗精神病药物恶性综合征 ）	
三氟拉嗪		
第二代抗精神病药物		

药物	一些潜在副作用	注释
阿立哌唑*		这类抗精神病药物较少引起震颤、肌肉僵硬、不自主运动（包括迟发性运动障碍）和 神经阻滞剂恶性综合征 ，但可能会出现其他副作用。
阿塞那平		
Brexipiprazole		
卡比拉嗪		
氯氮平		氯氮平 可导致骨髓抑制、白细胞减少和抽搐，所以较少使用。然而，该药物通常对其他抗精神病药物不起作用的患者有效。
伊潘立酮	头昏和体重增加（最常见）是重要的不良作用	
卢美哌隆	部分药物会增加腹部脂肪堆积、血液胆固醇水平异常、	
鲁拉西酮	高血压和胰岛素抵抗（ 代谢综合征 ）发生的风险	
奥氮平*		氯氮平 和 奥氮平 最易导致体重增加，而 阿立哌唑 最少导致。
帕利哌酮*		
Pimavanserin		
Quetiapine		
利培酮*		齐拉西酮 不导致体重增加，但可导致心电图异常。
Ziprasidone		
毒蕈碱受体激动剂		
Xanomeline-Trospium		可见胃肠道副作用（恶心、呕吐、便秘）和抗胆碱能副作用（如视物模糊）。
* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌肉 (IM) 注射剂。		

抗精神病药物的副作用

抗精神病药物有明显的副作用，可能包括

- 瞌睡
- 肌肉僵硬
- 震颤
- 体重增加

- 躁动

迟发性运动障碍是由长期使用抗精神病药物引起的一种多动性不自主运动障碍。第一代药物比第二代药物发病率高。迟发性运动障碍的特征是唇和舌皱起，或手臂或腿部扭动。即使停药后，迟发性运动障碍可能也不消退。持久的迟发性运动障碍尚无有效治疗方式，但氯氮平或喹硫平可以轻微缓解症状。然而研究发现，valbenazine 可有效改善迟发性运动障碍的症状。对于必须长期使用抗精神病药物的患者，应每 6 个月检查一次迟发性运动障碍症状。

与第一代抗精神病药物相比，第二代抗精神病药物出现迟发性运动障碍、肌肉僵硬和震颤的风险要低得多。但是，它们中有一些似乎可导致显著的体重增加。有些还会增加[代谢综合征](#)的发生风险。代谢综合征表现为腹部脂肪堆积、血甘油三酯（一种脂肪）水平升高、高密度胆固醇（HDL，一种“好”胆固醇）水平下降以及血压升高。另外，胰岛素的效果也下降（称作胰岛素抵抗），可增加[2 型糖尿病](#)的发生风险。氯氮平可导致癫痫发作或骨髓活动（包括生成白细胞）可能受到致命性抑制。因此，在美国，建议用氯氮平的患者至少在治疗开始后的最初 6 个月必须每周检测血液白细胞计数，以便在发现白细胞数目减少的首发征象后停药。

抗精神病药物的另一种非常罕见却十分危险的副反应是[抗精神病药恶性综合征](#)。其特征是肌肉强直、发热、高血压、精神功能的改变（例如意识模糊和倦怠乏力）。

[长 QT 综合征](#)是一种可能致命的心律失常，可由两类抗精神病药物中的多种药物引起。这些药物包括硫利达嗪、氟哌啶醇、奥氮平、利培酮和齐拉西酮。使用这些药物的患者需要[接受心电图](#)监测。